

내 LDL 목표는 왜 남과 다를까요

"검진에서 정상"과 "내 치료 목표"는 다릅니다. LDL 목표는 내 혈관의 위험도에 따라 정해지고, **일찍 시작해 꾸준히** 낮출수록 혈관에 쌓이는 부담이 줄어듭니다.

📌 목표는 위험도에 따라 다릅니다

나의 상황	LDL 목표
● 저위험 (위험인자 0~1개)	160 mg/dL 미만
● 위험인자 2개 이상	130 mg/dL 미만
● 당뇨 (10년 미만 · 위험인자·합병증 없음)	100 mg/dL 미만
● 당뇨 (10년 이상, 또는 위험인자·합병증 중 하나라도)	70 mg/dL 미만
● 경동맥 플라크* · 뇌졸중(뇌경색) · 과거력* · 일과성 허혈발작(TIA)*	70 mg/dL 미만
● 스텐트 · 심근경색 (+ 치료 전보다 50% 이상 감소)	55 mg/dL 미만

검진 '정상' ≠ 내 목표 · NOTE

검진표의 '정상'으로 보이는 수치도 **내 치료 목표보다는 높을 수 있습니다**. 위험이 높을수록 목표를 더 낮게 잡습니다.

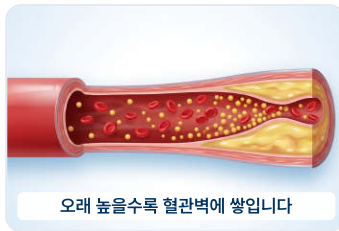
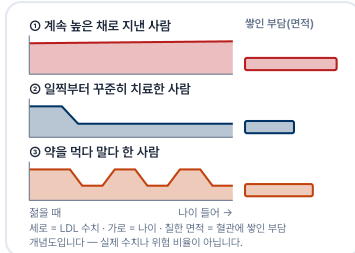
* 경동맥 플라크는 좁아진 정도와 전체 위험도를, 뇌경색·TIA는 원인(동맥경화 동반 여부)을 확인해 목표를 정합니다. 스텐트·심근경색은 55 미만과 함께 치료 전보다 LDL을 50% 이상 낮추는 것을 목표로 하며, 해당 고위험군에서도 50% 이상 감소를 함께 봅니다.

🔥 LDL은 간의 콜레스테롤 생성·처리 능력(유전적 요인)이 크게 좌우합니다

	LDL (나쁜 콜레스테롤)	중성지방
주로 정하는 것	음식보다 간의 생성·처리 능력	식사 · 술 · 체중
식사요법	모두에게 기본 치료 — 다만 식사만으로는 목표에 못 미치는 경우가 많습니다	생활습관에 잘 반응합니다

식사요법(포화지방 줄이기)은 모두에게 **기본 치료**이고 **약과 함께** 계속합니다. 다만 LDL은 **간의 생성·처리 능력(유전 영향)**이 커서 식사만으로는 목표에 못 미치는 경우가 많습니다 — 이때 **약이 필요합니다**.

📌 일찍, 꾸준히 — 위험은 '누적 노출'이 정합니다



2026 미국심장학회(ACC/AHA) 가이드라인의 메시지 — "일찍 시작할수록 좋다"

위험은 **LDL 곡선 아래 면적(누적 노출)**이 정합니다. 얼마나 높았는지 × 얼마나 오래였는지입니다.

일찍 시작할수록 그 이득이 오래 이어질 수 있습니다(레거시 효과).

🔍 약을 끊으면?

"나빠지는" 게 아니라 다시 올라갈 뿐입니다.
안경을 벗으면 다시 흐려지는 것과 같습니다.

좋아진 수치는 약이 일하는 중이라는 뜻입니다. 끊으면 올라간 기간만큼 **누적 노출이 다시 쌓입니다**.

☕ 커피와 식단도 LDL을 움직입니다

아메리카노 · 라떼

에스프레소처럼 종이필터를 거치지 않은 커피에는 **LDL**을 올리는 기름 성분(**카페인**)이 남아 있습니다.

믹스커피 · 종이필터 드립

LDL 면에서는 **괜찮습니다**.

👤 저탄고지

LDL에는 **가장 나쁜** 식단입니다.

❓ 흔한 오해 vs 사실

자주 듣는 오해 · MYTH	바로잡기 · FACT
"콜레스테롤은 몸에 꼭 필요하니 너무 낮추면 안 된다"	몸에 필요한 콜레스테롤은 세포가 스스로 만듭니다 .
"러닝하면 고기 먹어도 된다"	운동으로 LDL은 크게 안 내려갑니다. 포화지방은 여전히 LDL을 올립니다 .
"오메가3로 LDL을 잡는다"	오메가3는 중성지방을 일부 낮추고 항염증 효과가 있지만, LDL을 낮추지는 못합니다 .

함께 보기 — 진료실 설명 슬라이드: edu.gwanggyobarun.com/decks/endo/dyslipidemia/ · 스타틴 강도 표:

edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/statin-ldl-strength/ · 식단: edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/dyslipidemia-diet/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 제5판(2022) · 2026 ACC/AHA/Multisociety Dyslipidemia Guideline · EAS Consensus (Eur Heart J 2017) · LDL 누적 노출 (JACC 2020 · Nat Rev Cardiol 2024) · 커피 디테르펜 (Nutr J 2011) · 저탄고지 (Nutrients 2021)

본 자료는 일반 안내입니다. 개인별 LDL 목표와 약 조정은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endo/ldl-target-by-risk/

